

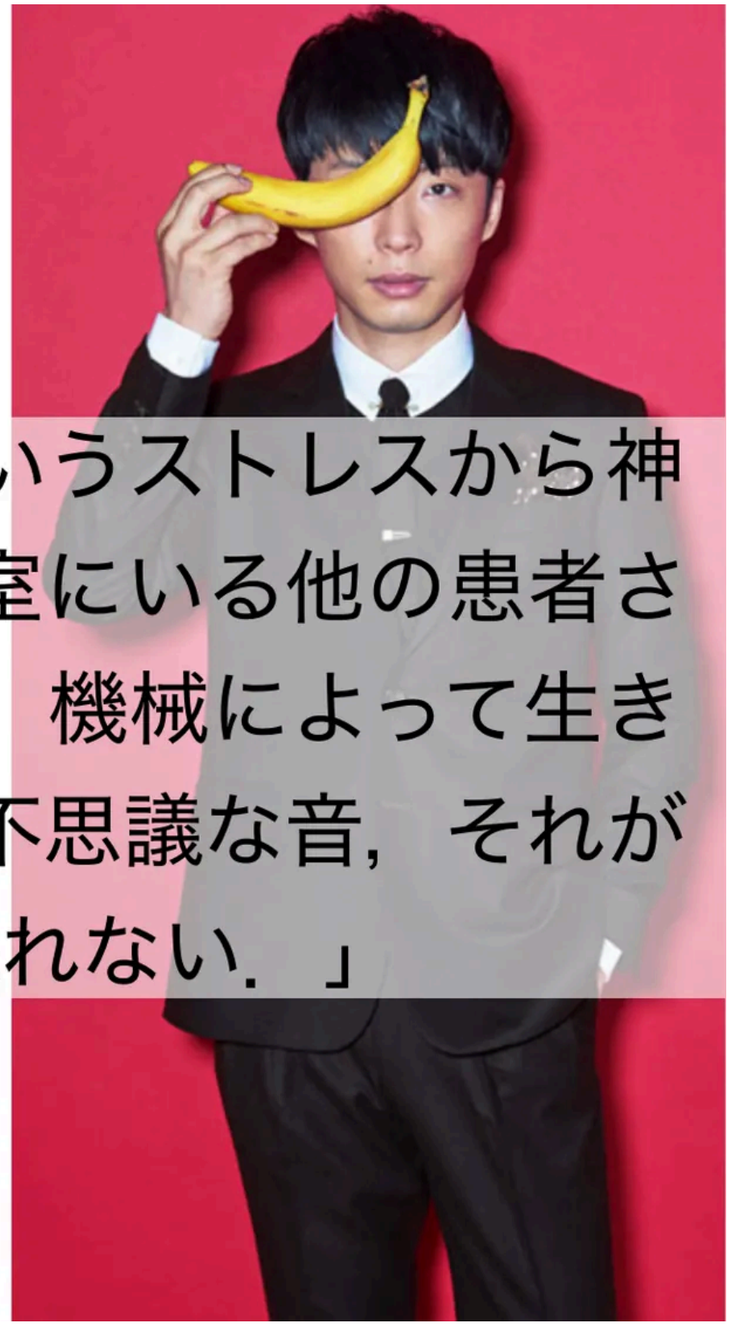
ICUの人間的ケア

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する

聖路加国際病院 集中治療科

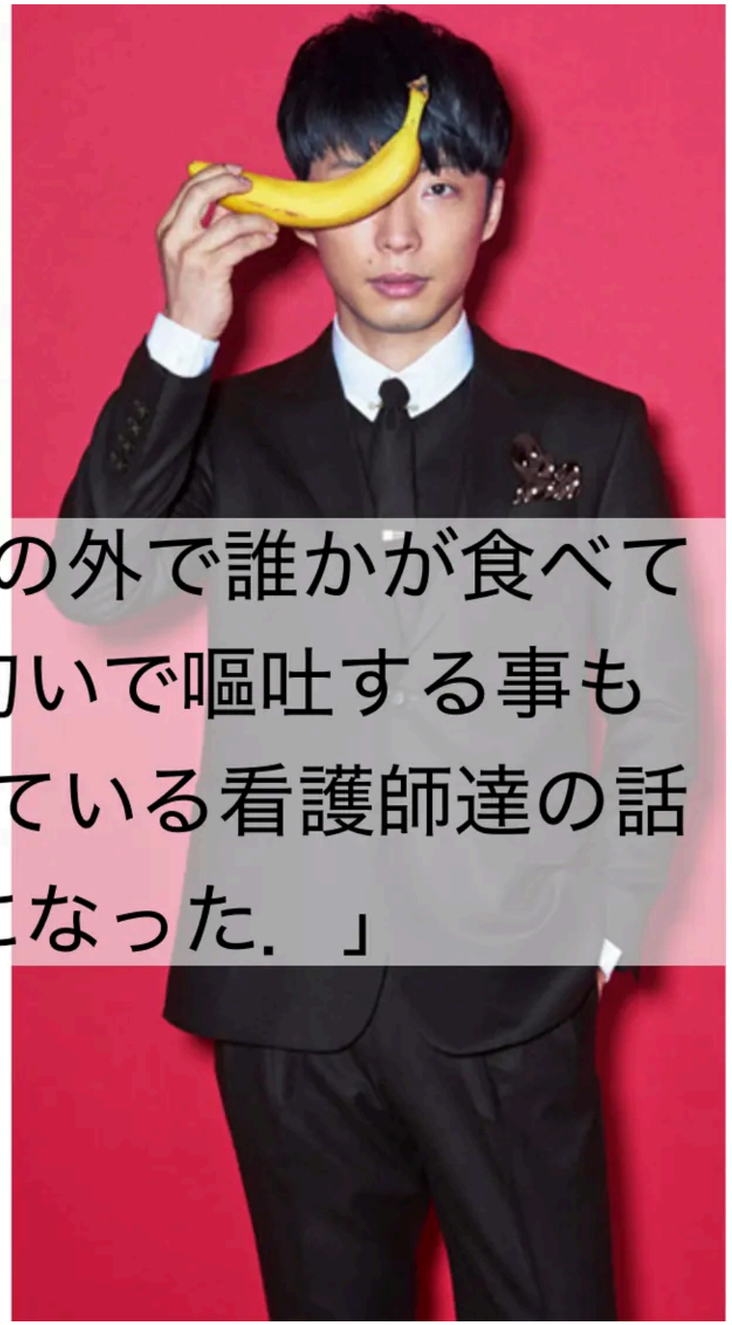


出典：『蘇る変態』星野源（2024年版スライドの引用）



「体が動かせなくなるというストレスから神経過敏になり，集中治療室にいる他の患者さんのうめき声，息づかい，機械によって生きている患者さんから出る不思議な音，それが気になって全く眠れない．」

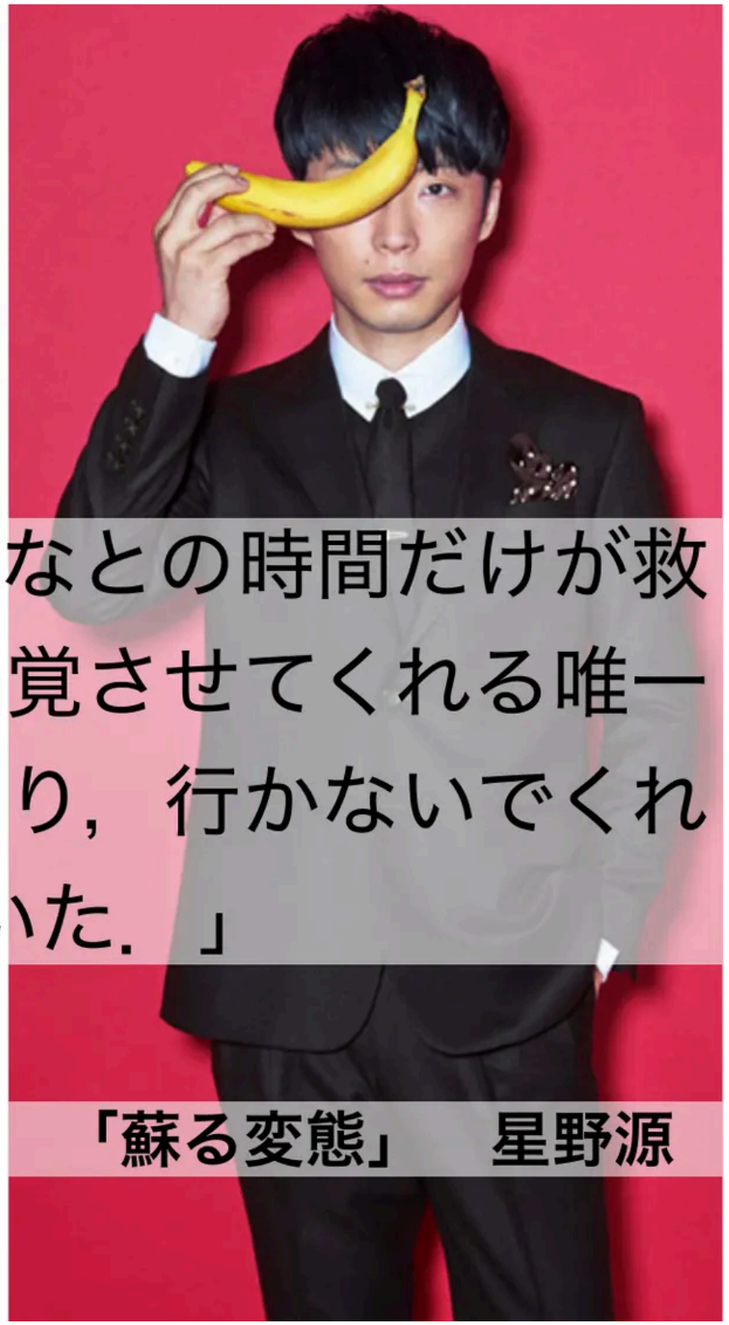
出典：『蘇る変態』星野源（2024年版スライドの引用）



「時には深夜に集中治療室の外で誰かが食べているであろうクッキーの匂いで嘔吐する事もあった．遠くの方で聴こえている看護師達の話し声に発狂しそうになった．」

出典：『蘇る変態』星野源（2024年版スライドの引用）

「お見舞いに来てくれるみんなとの時間だけが救いだった．自分が何者かを自覚させてくれる唯一の時間．皆が帰った後，ひとり，行かないでくれと声を殺して泣いた．」



出典：『蘇る変態』星野源（2024年版スライドの引用）

2つの言葉を分けて使う

Human care を積み重ねて、ICUを Humanization する

Humanization（目指す姿）

- 患者と家族を一人の人として
  尊重できるICUへ
- ケアだけでなく環境・仕組み・働き方まで
- ICU全体で整えていく考え方

Human care（日々の実践）

- 患者と家族を一人の人として尊重するケア
- 一人ひとりがベッドサイドで行う
- Humanizationを実現する手段

出典：Wilson CritCare2019、Nin Vaeza CCM2020

今日持ち帰る3つ

1

患者は起きている。聞けば苦痛は見える
口渇・不安・呼吸困難・睡眠を毎日尋ねる

2

善意は時刻表と実施率に落とす
「頼まれたらやる」は、ほぼ届いていない

3

家族と医療者も当事者
面会を開いて接点ごとに手当て。医療者のケアも人間化

出典は各章のスライド

最初に押さえる6つの数字

初日に口渇がある

66 %

症状で最多・最強

口渇を自分から訴えた

20 %

聞けば7割が答える

人工呼吸中の呼吸困難

約40 %

VASで平均45 mm

頼まれたら式の保湿

0.5 回/7時間

時刻表なら4.4回

ABCDEFと院内死亡

0.32 aHR

非ランダム化の関連

柔軟な面会の家族PTSD

21 %

通常の面会は30.5%

出典は各章のスライド（Saltnes-Lillegård、Doi、Demoule、VonStein、Pun、de Souza）

第 1 章

01

治療のフォーカス

臓器から、患者・家族・医療者へ

患者は何を語っているか

「人に囲まれていて、
これほど孤独になれるとは知らなかった」

「私は「4号室のあの患者」ではなかった」

15研究・10か国の患者と家族の語りの主題統合。出典：Nielsen JAdvNurs2023

フォーカスは、臓器から医療者へ広がった

臓器
数値を整える
深く鎮静

→

患者
痛み・せん妄
を本人に聞く

→

家族
PICS-F
パートナー

→

医療者
医療者のケア
人間化は能力

PAD 2013 → PADIS 2018・2025
眠らせ方から、痛み・不穏・せん妄の管理へ

前の段を捨てない
質の高い医療の上に Human care が乗る

出典：Nin Vaeza CCM2020、Lewis CCM2025、Hwang CCM2025、Topeli ICM2026

非人間化とは、人を「物」として扱うこと

患者が失うもの

- アイデンティティ
- 意思を伝える力
- 自分のことを伝える力
- 敬意とプライバシー

人間化の小さな実践

- 面会を開く・触れる
- 病気以外のことも話す
- せん妄の患者にも礼儀正しく
- 眼鏡・補聴器・口腔ケア

ICUの環境そのものが、非人間化を生みやすい

出典：Wilson CritCare2019

非人間化は、構造から生まれる

層	非人間的なケアを生む条件
社会・法制度	権利の否認、利益への関心、資源の不足
病院組織	断片化されたケア、ルーチン化、多重業務
個人	直接ケアの不足、患者の孤立、身体への偏り
くびれ	ベッドサイドに看護師がいること・情報提供

人間的なケアは「看護師だけの決断ではない」

砂時計モデル（看護師16名の研究）。出典：Beltrán Salazar 2016、Choi CritCare2026

国際的な枠組み：HU-CIの7領域

領域	中身
オープンドア	面会の開放。家族はケアのパートナー
コミュニケーション	チーム・患者・家族の対話、AAC
患者の well-being	痛み・口渇・寒さ・不眠・孤独・恐怖
医療者へのケア	燃え尽き・共感疲労・休む場所
PICS	退室後の不調の予防と早期発見
人間化された環境	自然光・プライバシー・居場所
終末期ケア	緩和ケアの統合、意思決定の支援

2014年スペイン発。160のアクション、200超のICUの自己評価で遵守率40〜60%。出典：Nin Vaeza CCM2020

第 2 章

02

深鎮静の時代は終わった

起きている患者は、苦痛を伝えられる

深鎮静は「既定値」ではなく「例外」

深鎮静の害（18項目の例）

- 人との接触の喪失
- せん妄・ICU-AW
- 人工呼吸と滞在の延長
- 永続的な認知障害

深い鎮静が要る5場面

- 非同調を伴う重症呼吸不全
- 筋弛緩薬の使用中
- てんかん重積
- 頭蓋内圧亢進の一部 など

人員不足は深鎮静の理由にならない

出典：Vincent ICM2016（eCASH）

鎮痛を先に、鎮静は最小に、ケアは最大に

鎮痛を先に
多角的鎮痛で
オピオイド減

→

鎮静は最小に
RASS −1〜0
ベンゾは限定

→

ケアを最大に
睡眠・離床
対話と面会

目指す姿は3C
Calm・Comfortable・Cooperative

興奮したら、まず原因
痛み・せん妄・非同調・便秘を探す

eCASH（早期の鎮痛・最小限の鎮静・最大限の人間的ケア）。出典：Vincent ICM2016

PADIS 2025：不安は新領域、推奨はまだない

問い	推奨（条件付き）	ポイント
鎮静薬	デクスメデトミジンを提案	せん妄 RR 0.55、徐脈 RR 1.65
リハビリ	強化リハビリを提案	ICU-AW RR 0.77（high）
睡眠	メラトニンの投与を提案	睡眠時間は延びない
不安	**推奨不能（根拠なし）**	まず測ることから
せん妄	抗精神病薬は推奨不能	原因の除去と非薬物的ケア

5つの問いに絞った Focused Update。強い推奨はゼロ。出典：Lewis CCM2025

起こした患者は、孤独と言えない苦しさを抱える

覚醒した患者の体験

- 言葉も道具も使えない
- 伝わらないと消耗する
- 人に囲まれていても孤独
- 病気以外の自分を見てほしい

1/4超

鎮静中断6時間後の重度の不安

伝えられないことが最悪の体験

人工呼吸の患者の語りの統合

起こすことは責任を引き受けること

次の章：聞いて、測る

出典：Baumgarten ScandJCaringSci2015、Lewis CCM2025、Nielsen JAdvNurs2023

第 3 章

03

聞かなければ存在しない

口渇・不安・呼吸困難・睡眠を尋ねる

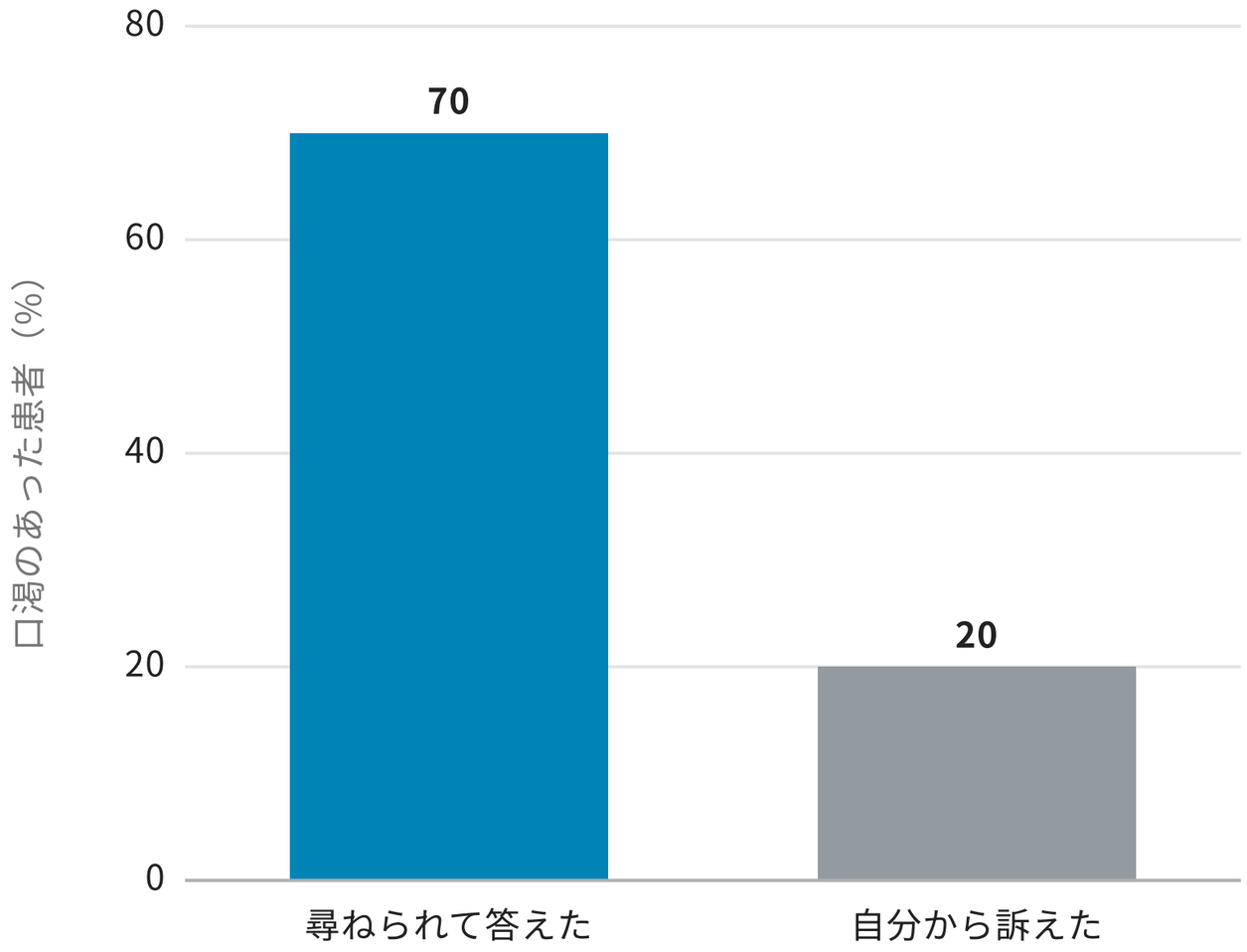
多いのは口渇、苦しいのは不安

指標	1位の症状	値
初日の有病率	口渇	66%
初日の平均の強さ（0〜10）	口渇	6.13
7日間の有病率	口渇	64%
初日の平均の苦痛度（0〜10）	**不安**	5.24
7日間の平均の苦痛度（0〜10）	**不安**	5.46

強さだけで優先順位をつけると、不安を取りこぼす

ノルウェー6 ICUの前向き観察（353名）。出典：Saltnes-Lillegård ICM2023

口渇の8割は、聞かれて初めて出てくる



待っていると2割
聞けば7割が答える

ケアの効果は1時間
1時間で元に戻った

湿っていても渇いている
口渇と口腔の水分は無相関

日本の大学病院ICUの観察研究（86例）。出典：Doi ICCN2021

毎日尋ねる5つ「iPad 2」

頭文字	訴え	聞き方の例
I	Insomnia（不眠）	夜は眠れましたか
P	Pain（痛み）	どこが、どのくらい痛みますか
A	Anxiety（不安）	怖い・落ち着かないことはありますか
D	**Dry mouth（口渇）**	喉が渇いていませんか
D	Dyspnea（呼吸困難）	息が苦しくないですか

答えられない患者には、うなずき・文字盤・指差しで答えられる形で聞く

Dが2つで「iPad 2」。出典：Chanques ICM2015 の表から

道具は、検証された集団で使う

測るもの	道具	注意
口渇	NRS 2問（強さ・苦しさ）	重度7〜10。TDSはICU未検証
睡眠	RCSQ（日本語版あり）	総得点だけ。非挿管・せん妄なし
挿管患者	TOURS（4項目）	1日2回。転帰との関係は未検証
不安	Faces Anxiety Scale	推奨はまだない
呼吸困難	VAS・NRS	人工呼吸中の約40%

ICU患者の最大半数は答えられない。「測れなかった」も記録する

出典：Halm 2022、Murata 2019、Richards 2020、Bodet-Contentin 2026、Lewis CCM2025

呼吸困難は、痛みと同じく緩和の対象

陽性なら探すこと

- 換気設定（非同調）
- 不安・痛み
- 分泌物・気道
- それでも残れば緩和

約40%

人工呼吸中に呼吸困難を報告

強さは VAS 45 mm

0〜100 mm の平均

モニターの値が良くても苦しい

すべての患者で同定・予防・緩和

出典：Demoule ICM2024（ERS/ESICM合同声明）

話せない患者に、伝える手段を渡す

渡す手段

- 眼鏡・補聴器・入れ歯を戻す
- はい／いいえの合図を決める
- 文字盤・筆談・タブレット
- 気管切開なら発声の手段

しないこと

- 患者の頭の上で話す
- 説明せずに処置する
- 患者の前で苦痛な発言
- 答えを急かす

非人間化は、コミュニケーションの場面で最も起きやすい

出典：Nin Vaeza CCM2020、Wilson CritCare2019、Nielsen JAdvNurs2023

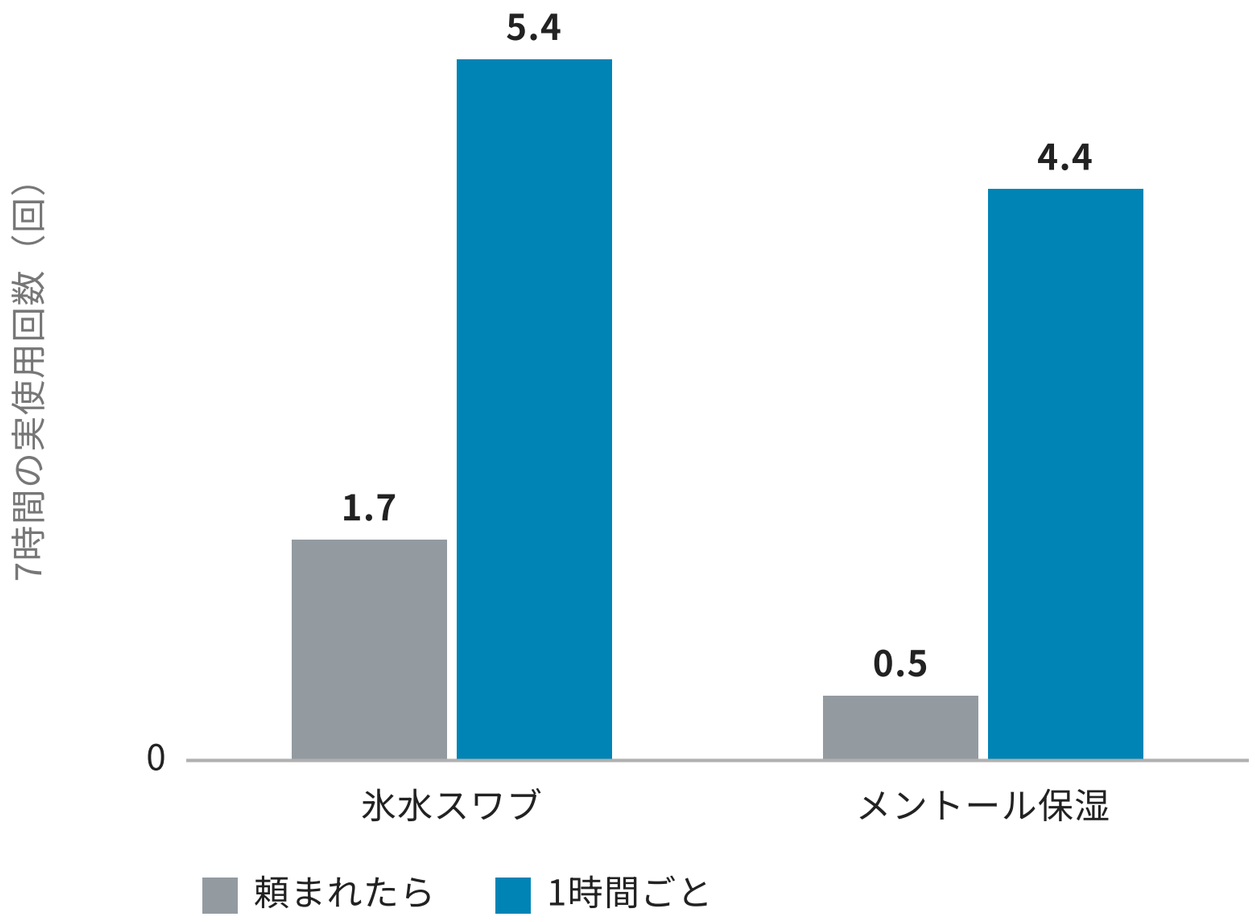
第 4 章

04

善意は時刻表に載せる

届いた割合が転帰を変える

「頼まれたらやる」は、ほぼ届いていない



0.5回
頼まれたら式の7時間の保湿

口渇の強さ −2.84 対 −1.68
P=.02、苦しさは有意差なし

非ランダム化・挿管例ほぼなし
強さを誇張しない

米国の内科系ICU 2ユニットの準実験（103例）。両群に同じ物品。出典：VonStein AJCC2019

1時間で戻るから、1時間ごとに

研究	デザイン	主な結果
Puntillo 2014	RCT・252名	口渇 5.9→3.6（対照4.7）
Kalfon 2017	クラスターRCT	口渇 2.32 対 3.40
Zhang 2021	RCT・61名	口渇 6.69→5.42
Lemyze 2020	前後比較・26名	ミント氷で 8.5→4.0
Doi 2021	観察・86名	効果が保たれたのは1時間

口渇は消えない。答えは「時刻表に載せる」

6研究の統合（AACNのレベル体系）。総合判定 level B。出典：Halm AJCC2022、Doi ICCN2021

ABCDEFは、届いた割合に比例して効く

アウトカム	完全実施（95%CI）
7日以内の院内死亡	aHR 0.32（0.17–0.62）
せん妄	aOR 0.60（0.49–0.72）
身体抑制の使用	aOR 0.37（0.30–0.46）
ICU再入室	aOR 0.54（0.37–0.79）
有意な痛みの報告	**実施割合とともに増加**

痛みの報告の増加は「見えるようになった」から

68 ICU・15,226例の質改善研究。非ランダム化の「関連」。出典：Pun CCM2019

身体抑制は、監視すべき有害事象

抑制するなら記録

- 理由（行動か、予防か）
- 部位の数と総時間
- 誰が決めたか・指示
- 家族への説明

8%

抑制されていた患者

医師の指示があったのは52%

家族への通知の確認は38%

抑制の前に原因を探す

痛み・口渇・尿意・せん妄

豪州・NZの44 ICU（627例）。有害事象は集めていない。出典：Maiden ICM2020、Nydahl ICM2024

第 5 章

05

人として扱う

つながりと、名前を呼ぶこと



人間的だと感じるのは「つながり」を感じたとき

誰の	主題
患者	医療者とのつながり：目を見る・微笑む・触れる
患者	自分とのつながり：情報・清潔ケア・整容
患者	外の生活とのつながり：ラジオ・花火
家族	唯一無二の人として世話されているのを見る
家族	そばにいる・触れる
家族	自分たちもケアされる

効いているのは高価な介入ではなく、小さなこと

15研究・10か国の主題統合。出典：Nielsen JAdvNurs2023

ラインの奥に踏み出す



毎回やること

- 名乗り、呼ばれたい名前で呼ぶ
- 目線を合わせ、本人に向かって話す
- 処置の前に、何をするか伝える
- 日付・時刻・場所・予定を伝える
- 帰り際に「ほかに困りごとは」

写真はイメージ。出典：Nielsen JAdvNurs2023、MacDonald ICM2021

その人を知るボードは、使って初めて効く

Get to Know Me Board

- 呼ばれたい名前
- 趣味・大切なもの
- 元気が出ること
- 回診でそれを見て話す

90% • 99%

患者・家族が「重要」と回答

家族の85%が「名前」を有用

患者は28%

「誰も使わなかった」17%

掛けてあるだけでは失敗

米国・患者29名、家族53名。単施設・対照群なし。出典：Ahmad JPatientExp2023

希望を叶える工夫は、受け入れられても効果は未確立

試みられていること

- 音楽（多くはヘッドホン）
- 動物の面会
- ICU専用のVR
- 家族の声をAIで再現（構想）

わかっていること

- 音楽の効果のエビデンスは限られる
- ペット面会は全工程2時間超
- VRは満足度8/10でも効果なし
- AIの声は有効性データなし

満足度は「受け入れられる」の指標で、「効く」の指標ではない

出典：Drop CritCare2026、Garcia Guerra JCC2019、Hosey 2018、Wicky CritCare2026

第 6 章

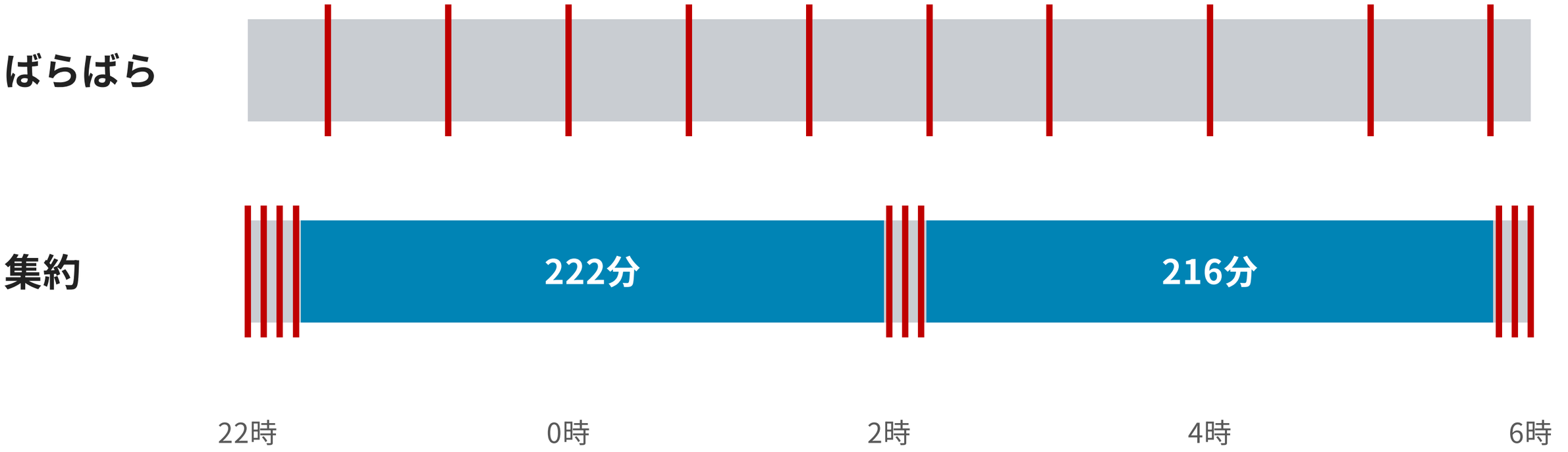
06

夜は静かに暗く

環境は単独でなくバンドルで



夜は、90分以上触らない時間をつくる



赤い線＝処置・観察で起こす　ティール＝90分以上途切れない時間

同じ回数のケアでも、まとめれば眠れる

模式図。時刻と回数は説明用。出典：Welbourne JICS2026

大きな音は、患者の耳のすぐ横から

今日確認できること

- アラーム音量が毎回標準に戻らないか
- 患者の頭の近くで申し送りしない
- 個室のドアの外で噂をしない
- 測るなら大きな音の回数

44〜66.5 dBA

ICUの平均音圧（WHOは昼35）

ピークは申し送りと回診

100 dBA超が1時間に2回

騒音の半分以上は職員の声

単発の掲示や教育は元に戻る

1,225万点の連続測定ほか。出典：Darbyshire Anaesthesia2019、Vrettou 2026、Welbourne JICS2026

単独の環境介入は、大規模RCTで陰性

介入・測定	わかっていること	言い方
夜の光	20 lux超が1時間に7〜16回	暗闇の断片化を見る
日中の高照度光	734名のRCTで陰性	単独では効かない
メラトニン	予防847名で陰性・PADISは提案	環境を整えたうえで
耳栓・アイマスク	文献間で食い違う	バンドルの一部
睡眠覚醒調節薬	せん妄 RR 0.60・低確実性	全例には使わない

光・耳栓・静穏時間は、ばらばらでなくバンドルで

出典：Luetz ICM2023、Lewis CCM2025、Niederer CritCare2026、de Oliveira CCM2025

ICUの設計も治療の一部。約束は環境の指標まで

わかっていること

- 個室化で残響0.7→0.3秒
- 遮音0→21 dBA
- 測定は患者が入る前の空室
- 家族の居場所は best practice

提案するときは

- 何を測るかを着工前に決める
- 体験と環境の指標で約束する
- 家族と職員の居場所も同じ計画に
- 価値で定義する

「せん妄が減ります」と言って予算を取らない

出典：Tronstad CritCare2023、Hwang CCM2025、Greco ICM2026

第 7 章

07

家族はケアのパートナー

面会を開き、接点に手当てを



PICS-Fは家族の20〜60%、生活まで揺さぶる

家族に起きること

- 不安・抑うつ・PTSD
- 仕事を離れる
- 貯蓄を失う
- 時間では解決しないことも

20〜60%

PICS-Fが起きる家族

1か月で44.9%が離職

1年で36.7%が貯蓄を失う

家族の約3割にPTSD症状

方針と指標は疾患と稼働だけ

出典：Schaller ICM2026、Shirasaki AcuteMedSurg2024、Azoulay ICM2026

日本の家族：面会は短く、つらさは1年続く

日本の現在地

- 面会は午後の数時間
- 家族控室に個室が少ない
- 家族のつらさは減らない
- 精神科受診は15%

79.5%
三次救急ICUで面会を制限（中央値180分）

控室のプライバシー確保 32.6%
全国151施設の調査

家族のPICS-F 1年後も42%
関連したのは患者の精神症状（aOR 3.71）

出典：Shirasaki CritCare2025（151施設の質問紙調査）、Shirasaki CCM2026（ILOSS・21 ICU・94組）

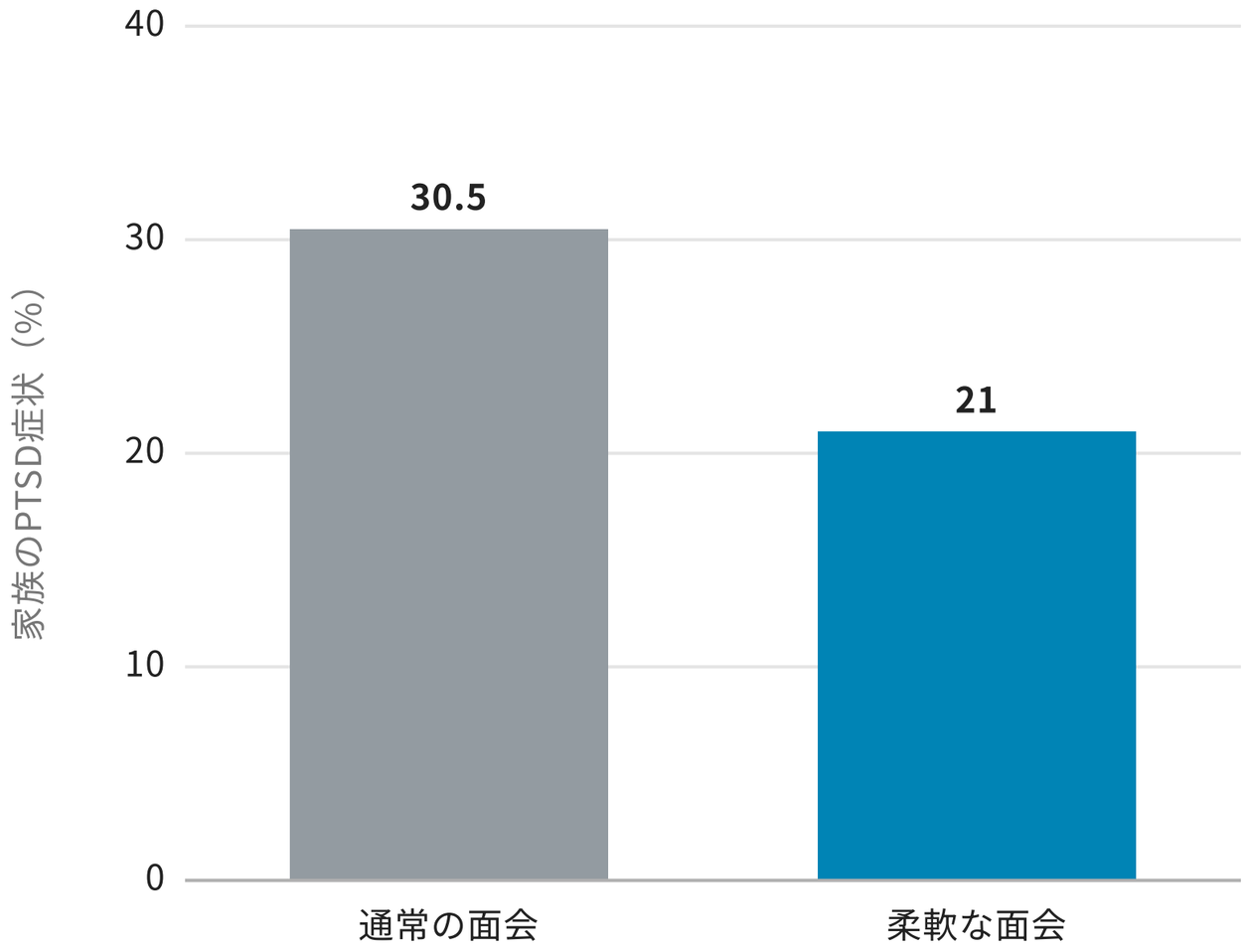
面会の緩和が、唯一の「強い推奨」

ステートメント	強さ（確実性）
面会を緩和した方針をICUの既定とする	**強い（low）**
家族向けの教育プログラム	条件付き（moderate）
回診への同席・ケアへの参加	条件付き（low）
家族カンファの標準化とVALUE	条件付き（low）
家族向けの意思決定支援ツール	推奨せず

家族は visitor ではなく partner in care

SCCM家族中心ケアガイドライン2024（17ステートメント）。2017年版を置き換え。出典：Hwang CCM2025

柔軟な面会が効くのは、家族の心理



患者のせん妄は差なし
18.9% 対 20.1%

面会4.9時間 対 1.5時間
構造化ミーティングと冊子つき

感染・燃え尽きは増えない
時間だけ延ばすと外れうる

36 ICU・1,685例のクラスター交差RCTと12か月解析。出典：Rosa JAMA2019、de Souza ICM2024

家族の引き金は、滞在の全体に散らばる

初回面会の前	チューブの本数・目が開いているか・抑制・むくみを予告
待っている間	家族自身の睡眠と食事を尋ねる
覚醒の前日	せん妄は起こりうる・一過性・人格ではないと伝える
看取り	モニター表示を消すかを選んでもらい、死戦期呼吸を先に伝える
一度の面談に頼らない	それぞれの接点に予告と説明を置く

フランス14 ICU・家族17人の質的研究。出典：Kentish-Barnes ICM2026

面談はVALUEで

頭文字	すること
V　Value	家族の言ったことの価値を認める
A　Acknowledge	家族の感情に気づいていると伝える
L　Listen	よく聴く
U　Understand	**患者がどんな人だったかを尋ねる**
E　Elicit	家族からの質問を引き出す

患者を人として語る一文と、家族の体調を聞く一文を

日本集中治療医学会のPICS解説ページの訳を参考にした。SCCM 2024でも条件付きで推奨

担い手を1人足しても、家族の心理は動かなかった

試験	足したもの	家族の心理
PARTNER	多職種チームの支援	差なし
FICUS	指名の家族ナース	8項目すべて差なし
ファシリテーター	看護師が3か月伴走	抑うつ差 −0.07点
Caregiver Pathway	4つの時点で接点	IES-R 6.8点低下

効いたのは面会を開くことと、接点を複数置くこと

出典：White NEJM2018、Riguzzi ICM2026、Creutzfeldt CCM2026、Watland ICM2025

陰性試験は「無効」の証明ではない

なぜ陰性になりうるか

- 割付単位が16施設だけ
- 予後因子の約45%が偏りうる
- 長期の不安・抑うつは動かず
- 動いたのは医療チームとの関係

次の照準

- 全家族に一律に足さない
- 負担の大きい家族に絞る
- 対立・代理意思決定者の不在
- 短期の当事者中心アウトカム

「効果なし」と「まだ測れていない」を分けて読む

出典：Martín Delgado ICM2026、Aslakson CCM2026（いずれもエディトリアル）

第 8 章

08

ICUのあとと医療者

回復は続き、人間的なケアは能力



PICSは、入室の日から動く回復の過程

ゴールは生活に戻ること

- 家庭
- 趣味
- 仕事
- 家族と一緒に

64%

J-PICS：日本のICU患者のPICS

確実なのはICUにいる間の予防

浅い鎮静・せん妄予防・早期離床

退室時に4項目を手渡す

リハ・離床・栄養・残るリスク

出典：Schaller ICM2026、Kawakami CritCare2021、Iwashyna AnnInternMed2010

ICUダイアリーの価値は、つながりにある

わかったこと

- 3か月PTSD 29.9% 対 34.3%
- 差なし（657例・P=0.39）
- 妄想的記憶38.5%がPTSDに
- 健忘にしてもPTSDは減らない

どう使うか

- 目的をPTSD予防にしない
- 記憶の補完と家族の支えに
- 医療者も人間化される
- 記憶を消す鎮静はしない

ダイアリーは「医療スタッフと患者の双方を人間化した」

出典：Garrouste-Orgeas JAMA2019、Kooken ICM2025、Nielsen JAdvNurs2023

医療者へのケア：共有する傷の5つの枠組み

頭文字	中身
A　家族を受け入れる	家族支援を職務の必須要素に
B　燃え尽きを防ぐ	個人の研修より、人員配置と心理支援
C　倫理的な風土	関係性の能力を訓練する
D　時間を確保する	時間は関係性ケアの通貨
E　励ます	守られた時間と研修の資金

疲れ切ったチームは、人間的なケアを届けられない

意見論文で独自データなし。出典：Azoulay ICM2026、Nin Vaeza CCM2020、Takatani CritCare2026

燃え尽きは、職場の仕組みで下がる

Hello trial（6要素を4週間）の例

- 朝の挨拶
- 感謝のメッセージ
- リーダーの率先
- 費用はほぼかからない

aOR 0.56

バーンアウト 63.3% → 52.2%

モラルディストレスの原因は構造

病院の文化・職種の階層・治療を
減らす手続きの不足

効くのは研修より権限

看護師が緩和ケア・倫理コンサルを依頼できる

出典：Azoulay ICM2025（60か国370 ICUのクラスターRCT）、Brender JAMANetwOpen2025（米国4病院122人の面接）

「不適切なケア」の迷いが、離職につながる

関連したもの

- 終末期の決定を避ける文化
- 相互尊重（守る側）
- 倫理的な気づき（守る側）
- 同席させるだけでは効かない

26%

不適切なケアを提供していると感じる

離職意向 aOR 1.6

感情的消耗も独立して関連（β 0.4）

迷いを言える対話の質

相互尊重・倫理的な気づき 各 aOR 0.7

出典：Hesselink ICM2026（オランダ47 ICU・1,058人の横断調査）、Papazian ICM2023（25研究のメタ解析）

人間的なケアは、教えて評価する能力

枠組み
共感・倫理
共同意思決定

→

教育
家族面談を
訓練する

→

評価
直接観察
PREMs

→

成果
現場で
続いているか

家族面談をシミュレーション
急変対応と同じように多職種で

善意だけでは続かない
研修を受けた、で終わらせない

新しいデータのない概念論文。出典：Topeli ICM2026、Hwang CCM2025

第 9 章

09

聖路加ICUの Hotel ICU

6つの柱と、ICUの前・中・後をつなぐケア

Hotel ICU：6つの柱

医療者へ

04 働きやすい環境
05 スタッフの Wellbeing
06 プロとしての満足感



患者さん・ご家族へ

01 ホスピタリティー
02 Human Care
03 質の高い医療

聖路加ICUのチームTシャツと同じ順。出典：Hotel ICU 共有ページ（2026年度版）

ICUの前・中・後をつなぐ4つの施策

ICU前
つなぐシート
その人を知る

→

ICU中
Helloボード
その人らしさ

→

ICU中
ケアラウンド
その場で解決

→

ICU後
ダイアリー
PICSの説明

いまの力点はケアラウンド
ICUにいる間の予防へ

文献との対応
その人を知るボード・日記

出典：Hotel ICU 共有ページ（2026年度版）

退室後訪問で聞いた声（2024年度）

多職種で訪問

22 人

4日以上の33人のうち

つらかったことがあった

13 人

呼吸に関する記憶が多い

口渇を覚えていた

約3 割

22人のうち7人

- 見えた限界：苦痛を知るのは、それが「過去のこと」になってから
- だから力点を、ICUにいる間の予防＝ケアラウンドへ移した

2024年12月〜2025年2月の集計。出典：Hotel ICU 共有ページ

ケアラウンド：多職種で週2回、ベッドサイドへ

	どう回っているか
誰に	意思の疎通ができる方。せん妄・挿管中も対象
誰が	医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士の2人以上
いつ	週2回（月・金）。1人約10分
何を	30項目で見て、その場で介入し記録
翌日	受け持ち看護師が結果を評価

パイロットで最も多かった訴えは口渇。その場で対応できている

2026年4月から。30項目（身体15・環境4・心5・尊厳と対話6）。出典：Hotel ICU 共有ページ

ICUを出たあとも、つながる

ICUダイアリー

- 人工呼吸24時間以上の見込みの方
- ICUの看護師が書き始める
- 病棟で本人に手渡し、記憶を伺う
- 渡せないときはご家族へ

PICSの説明

- パンフレットを患者さんとご家族へ
- 体・心・認知の不調を伝える
- 相談先を明記
- 院内のPICSチームで対応

文献どおり、ダイアリーは記憶の補完とつながりのために

出典：Hotel ICU 共有ページ（2026年度版）

言えること・言えないこと

介入	言えること	言えないこと
口渇ケア	口渇が下がる	せん妄が減る
ABCDEF	用量反応の関連	因果としての死亡減少
柔軟な面会	家族の心理の改善	患者のせん妄の減少
ICUダイアリー	家族・医療者とのつながり	患者のPTSD予防
環境・設計	環境の指標の改善	転帰の改善

効果が未証明でも、やらなくてよいわけではない

出典：Halm 2022、Pun CCM2019、Rosa JAMA2019、Garrouste-Orgeas JAMA2019、Tronstad 2023

明日からの3つ

1

患者の声に耳を傾け、手を添える
毎日 iPad 2 を尋ね、口渇ケアを時刻表に

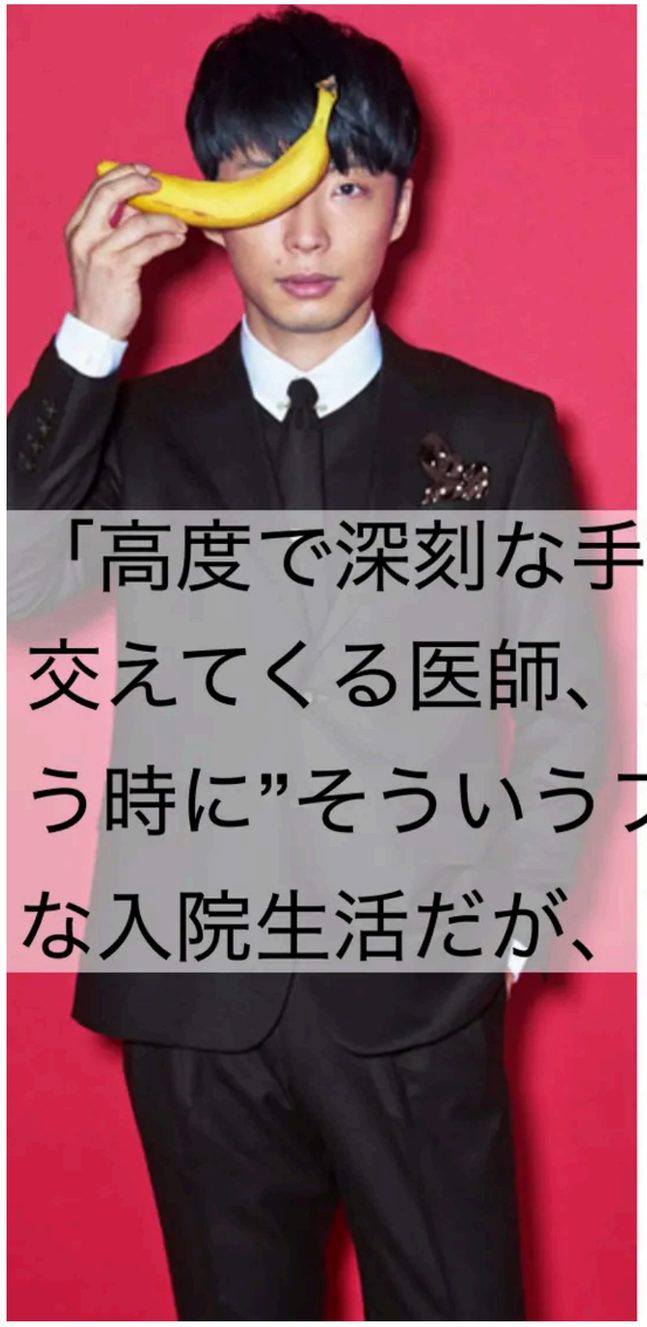
2

人として向き合う
名前を呼び、処置の前に声を掛ける

3

家族と仲間にも目を向ける
初回面会の前に予告。夜は90分触らない

2024年の Key message を更新



「高度で深刻な手術内容を説明しながら下ネタを交えてくる医師、美人看護師に座薬を入れてもらう時に”そういうプレイだ”と妄想する自分。過酷な入院生活だが、**面白さが辛さに勝った**のだ。」

出典：『蘇る変態』星野源（2024年版スライドの引用）

確認クイズ：◯か×か

Q1 柔軟な面会は、患者のせん妄を減らす

Q2 口渇は、聞かなくても患者が訴えてくれる

Q3 口が湿っていれば、口渇はない

Q4 ABCDEFは実施割合が高いほど転帰が良い

Q5 ICUダイアリーは患者のPTSDを防ぐ

確認クイズの答え

Q1 ✕ 効いたのは家族の不安・抑うつ・PTSD

Q2 ✕ 自分から訴えたのは20%だけ

Q3 ✕ 口渇と口腔の水分は相関しない

Q4 ◯ ただし非ランダム化の関連

Q5 ✕ 657例のRCTで差なし

出典：Rosa JAMA2019、Doi ICCN2021、Pun CCM2019、Garrouste-Orgeas JAMA2019

ご清聴ありがとうございました

元気とユーモアを忘れずに、Human care の実践を

聖路加国際病院 集中治療科